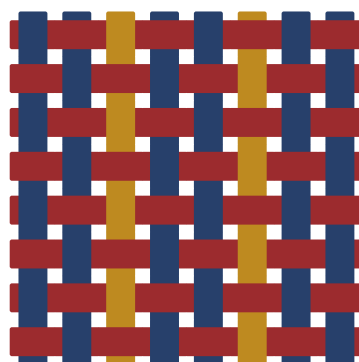




实验诊断主观病例分析 16 分 模板库

NovaForge 视觉重排版 • 内容保持不变

Codex

2026-06-29

dyed in indigo, madder & weld; ruled in iron-gall. woven on LOOM.

CONTENTS

1 实验诊断主观病例分析 16 分模板库	3
1.1 Part 1: 主观病例分析通用答题框架	3
1.1.1 1. 考场固定顺序	3
1.1.2 2. 16 分题抢分分布	3
1.1.3 3. 万能句式	3
1.1.4 4. 考研老师资料可搬用的病例题眼	4
1.2 Part 2: 高频病例分析模板	4
1.3 模板 1: 感染/炎症类	4
1.4 模板 2: 心肌损伤/心衰/胸痛类	5
1.5 模板 3: 黄疸/肝胆胰类	5
1.6 模板 4: 贫血/溶血/白血病/DIC 类	6
1.7 模板 5: 肾功能/尿液/泌尿系统类	7
1.8 模板 6: 体液检查类	8
1.9 模板 7: 消化道出血/消化道肿瘤类	9
1.10 模板 8: 内分泌/代谢/中毒类	9
1.11 模板 9: 外伤/急腹症/休克类	10
1.12 模板 10: 自身免疫/风湿免疫相关类	11
1.13 Part 3: 53 题归类索引	12
1.14 Part 4: 最后 20 分钟背诵版	13
1.14.1 1. 感染题	13
1.14.2 2. 心梗/心衰题	13
1.14.3 3. 黄疸题	13
1.14.4 4. 贫血/溶血题	13
1.14.5 5. DIC/白血病题	13
1.14.6 6. 肾炎/尿液题	13
1.14.7 7. 胸水/脑脊液题	14
1.14.8 8. 消化道出血/肿瘤题	14
1.14.9 9. 甲亢/糖尿病/中毒题	14
1.14.10 10. 外伤/急腹症题	14
1.15 最后一页: 不会写时的保底答案	14
1.16 Part 5: 主观题示范答案骨架	15
1.16.1 1. 肺部感染类示范	15
1.16.2 2. 胸水类示范	15
1.16.3 3. 黄疸类示范	15

1.16.4	4. 贫血类示范	16
1.16.5	5. 白血病/DIC 类示范	16
1.16.6	6. 肾炎/尿液类示范	17
1.16.7	7. 心梗/心衰类示范	17
1.16.8	8. 脑膜炎/脑脊液类示范	17
1.17	Part 6: 主观题阅卷友好写法	18
1.17.1	1. 诊断写法	18
1.17.2	2. 依据写法	18
1.17.3	3. 鉴别写法	18
1.17.4	4. 补充检查写法	18

■ 1 实验诊断主观病例分析 16 分模板库

来源：53 个主观病例分析题、实验诊断资料、考研老师整理资料。

用法：不是逐题背答案，而是背“结论句 + 依据句 + 鉴别句 + 补充检查句”。

注意：考研资料只取老师整理的诊断公式、辅助检查和鉴别要点；不采信 OCR 中的答案字母，不做原题押题。

1.1 Part 1：主观病例分析通用答题框架

一、诊断及诊断依据

(一) 诊断：本例首先考虑 _____。

(二) 诊断依据：

1. 病史：_____。
2. 体征：_____。
3. 实验室/辅助检查：_____ 升高/降低/阳性，提示 _____。

二、鉴别诊断

1. 需与 _____ 鉴别：鉴别点为 _____。
2. 需与 _____ 鉴别：可通过 _____ 进一步鉴别。

三、进一步检查

1. 完善 _____ 以明确诊断。
2. 完善 _____ 以判断病情或并发症。
3. 完善 _____ 以寻找病因或进行鉴别。

四、总结

综合病史、体征及实验室检查，本例考虑 _____ 可能性大。

1. 考场固定顺序

2. 16 分题抢分分布 多数病例原题结构接近：

诊断及诊断依据：8 分

鉴别诊断：5 分

进一步检查：4 分

实际考试若总分 16 分，可按这个比例压缩：

- 诊断 2-3 分：先写主要诊断，别空。
- 依据 6-7 分：病史、体征、实验室检查各写 1-3 条。
- 鉴别 3-4 分：列 2-3 个疾病，每个写一个鉴别点。
- 补充检查 3-4 分：写最能明确诊断的检查。

本例考虑 _____，依据为 _____。

实验室检查 _____ 升高/降低/阳性，提示 _____。

需与 _____ 鉴别，鉴别点为 _____。

建议完善 _____、_____、_____。

3. 万能句式

4. 考研老师资料可搬用的病例题眼 这些句子可以直接变成“诊断依据”或“鉴别点”:

慢性或反复咳嗽、咳痰 N 年, 伴吸烟史, 肺功能示持续气流受限, 支持 COPD。
慢性咳嗽、大量脓痰、反复咯血, 既往百日咳/麻疹史, HRCT 支持支气管扩张。
发作性咳嗽、喘息、胸闷, 双肺哮鸣音, 肺功能检查支持支气管哮喘。
受凉后寒战高热、铁锈色痰、肺实变体征, 支持肺炎链球菌肺炎。
低热、盗汗、消瘦, 咳嗽咯血, 上肺病灶, 支持肺结核。
突发呼吸困难、胸痛, P2 亢进, 血气 $\text{PaO}_2\downarrow$ 、 $\text{PaCO}_2\downarrow$, 需考虑肺栓塞, 首选 CTPA 明确。
急性胰腺炎/重症感染后出现呼吸困难, 血气 $\text{PaO}_2\downarrow$ 、 $\text{PaCO}_2\downarrow$ 、 $\text{pH}\uparrow$, 两肺浸润影, 考虑 ARDS。
 $\text{PaO}_2<60\text{mmHg}$ 伴 $\text{PaCO}_2>50\text{mmHg}$, 提示 II 型呼吸衰竭。
不能平卧、夜间阵发性呼吸困难、双肺底湿啰音, 支持左心衰。
颈静脉怒张、肝大、肝颈静脉回流征阳性、下肢水肿, 支持右心衰。
持续胸痛、硝酸甘油无效、心肌坏死标志物升高、心电图改变, 支持急性心肌梗死。
胸水 $\text{ADA}>45\text{U/L}$ 且淋巴细胞为主, 支持结核性胸腔积液。
胸水 WBC 明显升高、中性粒细胞为主、 $\text{pH}<7.30$, 支持脓胸。
血性胸水、 $\text{ADA}<45\text{U/L}$ 、细胞学阳性或 CEA 升高, 支持恶性胸腔积液。
慢性乙肝或肝硬化史、肝区痛、肝脏肿大、AFP 升高, 支持原发性肝癌。
上感后 1-3 周出现血尿、水肿、高血压, C3 下降、ASO 升高, 支持急性肾小球肾炎。
上感后 1-3 天即出现血尿, 更支持 IgA 肾病。
急性肾炎表现伴少尿/无尿、Cr 重度升高, 应考虑急进性肾小球肾炎。

1.2 Part 2: 高频病例分析模板

1.3 模板 1: 感染/炎症类 【题型】

发热、咳嗽咳痰、腹泻、脑膜刺激征、白细胞升高、局部感染体征。

【题干关键词】

急性起病、寒战高热、咳嗽咳痰、脓血便、腹痛、脑膜刺激征、WBC 升高、中性粒细胞比例升高。

【需要先判断什么】

先判断是不是感染, 再判断感染部位和病原倾向。

【答题步骤】

1. 先写感染部位诊断: 肺炎、菌痢、脑膜炎、胆管炎、肾盂肾炎等。
2. 写急性起病和局部症状。
3. 写实验室支持: WBC、中性粒细胞、病原学、培养。
4. 鉴别其他感染或非感染性疾病。
5. 补充检查写培养、药敏、影像或体液检查。

【必须写出的检验依据】

WBC 升高 + 中性粒细胞比例升高, 提示细菌感染。
大便 WBC/RBC 增多, 支持细菌性痢疾或肠道感染。
脑脊液压力、外观、细胞数、蛋白、糖、氯化物可用于脑膜炎鉴别。
痰培养、血培养、便培养、脑脊液培养用于病原学诊断。

【鉴别诊断】

肺部感染: 肺结核、肺癌、肺脓肿、其他病原体肺炎。
肠道感染: 急性坏死性肠炎、阿米巴痢疾、肠套叠。
脑膜炎: 化脓性、结核性、病毒性脑膜炎相互鉴别。

【补充检查】

血常规复查、CRP/PCT、病原学检查、培养 + 药敏; 肺部感染加胸片/CT; 肠道感染加便培养; 脑膜炎加腰穿和脑脊液检查。

【考场可直接套用答案】

本例考虑细菌感染性疾病, 依据为急性起病, 伴发热及相应部位症状; 查体有局部感染体

征；血常规示 WBC 升高、中性粒细胞比例升高，提示细菌感染。需与其他病原体感染及非感染性疾病鉴别，建议完善病原学检查、培养加药敏及相关影像/体液检查。

【易漏得分点】

不要只写“感染”，必须写感染部位。

不要忘记“培养 + 药敏”。

脑膜炎题一定写脑脊液压力、外观、常规、生化、细菌学。

1.4 模板 2：心肌损伤/心衰/胸痛类 【题型】

胸痛、心悸、呼吸困难、不能平卧、下肢水肿、心电图异常、心肌标志物。

【题干关键词】

持续胸痛、硝酸甘油无效、大汗、糖尿病/高血压/吸烟史；夜间憋醒、不能平卧、肺底湿啰音、颈静脉充盈、肝颈静脉反流阳性、下肢水肿。

【需要先判断什么】

先判断是急性冠脉综合征/心肌梗死，还是心功能不全；有时两者并存。

【答题步骤】

1. 先写主要诊断：急性心肌梗死、心绞痛、高血压性心脏病、心力衰竭等。
2. 写危险因素：年龄、高血压、糖尿病、吸烟。
3. 写症状体征：持续胸痛、呼吸困难、不能平卧、湿啰音、水肿。
4. 写实验室和辅助检查：心电图、cTn、CK-MB、胸片、超声心动图。
5. 鉴别心绞痛、夹层、肺栓塞、心肌病、瓣膜病。

【必须写出的检验依据】

cTn 升高支持心肌损伤，是心肌梗死重要指标。

CK-MB 可辅助判断心肌损伤和动态变化。

BNP/NT-proBNP 可辅助判断心衰，资料未覆盖具体数值时不硬写。

血气分析可用于呼吸困难、缺氧、酸碱状态判断。

【鉴别诊断】

心绞痛：胸痛较短，休息或硝酸甘油可缓解，心肌坏死标志物不升高。

主动脉夹层：撕裂样疼痛、血压/脉搏差，需影像学鉴别。

肺栓塞：突发呼吸困难、胸痛、低氧，D-二聚体和 CTPA 辅助。

扩张型心肌病、风湿性心脏病：靠病史、心超和瓣膜情况鉴别。

【补充检查】

心电图动态观察、cTn/CK-MB 动态复查、心脏超声、胸片、血气分析、电解质、血糖、血脂、肝肾功能。

【考场可直接套用答案】

本例考虑急性冠脉综合征/急性心肌梗死可能，依据为持续胸痛、硝酸甘油缓解差，并有高血压、糖尿病或吸烟等危险因素；若出现呼吸困难、肺底湿啰音，提示急性左心衰。建议完善心电图、肌钙蛋白、CK-MB、心脏超声及血气、电解质等检查。

【易漏得分点】

胸痛题不要只写“冠心病”，要区分心绞痛和心肌梗死。

心衰题要分别写左心衰和右心衰依据。

心梗题一定写“心电图 + 心肌坏死标志物”。

1.5 模板 3：黄疸/肝胆胰类 【题型】

皮肤巩膜黄染、尿色深、皮肤瘙痒、右上腹痛、肝功能异常、胆管扩张、肝占位。

【题干关键词】

ALT/AST 升高，提示肝细胞损伤；DBIL、ALP、GGT 升高明显，提示胆汁淤积或梗阻；尿胆红素阳性提示结合胆红素升高；尿胆原阳性可见于肝细胞性黄疸或溶血。

【需要先判断什么】

先判断黄疸类型：肝细胞性、梗阻性、溶血性。

【答题步骤】

1. 先写“黄疸原因待查”，再写最可能类型。
2. 写黄疸表现：皮肤巩膜黄染、尿色深、瘙痒。
3. 写检验组合：总胆红素、直接胆红素、ALT/AST、ALP/GGT、尿胆红素/尿胆原。
4. 写影像依据：B超/CT有无胆管扩张、胆囊增大、肝占位。
5. 鉴别三类黄疸。

【必须写出的检验依据】

ALT/AST 升高：肝细胞损伤。

DBIL 升高 + ALP/GGT 升高明显：胆汁淤积或梗阻。

尿胆红素阳性：结合胆红素升高。

间接胆红素升高 + 尿胆红素阴性 + 尿胆原强阳性：偏溶血性黄疸。

AFP 明显升高 + 乙肝/肝硬化背景 + 肝占位：支持原发性肝癌。

【鉴别诊断】

急性黄疸型肝炎：黄疸前期乏力、纳差、恶心，ALT/AST 升高，病毒学检查支持。

梗阻性黄疸：进行性黄疸、瘙痒、尿色深，DBIL/ALP/GGT 升高，胆管扩张。

溶血性黄疸：贫血、网织红细胞增高、间接胆红素升高，尿胆红素阴性。

【补充检查】

肝功能全套、总/直接/间接胆红素、ALP、GGT、病毒性肝炎标志物、腹部 B 超、CT/MRCP、AFP，必要时病理检查。

【考场可直接套用答案】

本例考虑黄疸原因待查，结合皮肤巩膜黄染、尿色深及胆红素异常，需判断黄疸类型。若直接胆红素、ALP、GGT 明显升高并有胆管扩张，支持梗阻性黄疸；若 ALT/AST 明显升高并有肝炎前驱症状，支持肝细胞性黄疸。建议完善肝功能、肝炎病毒学指标、腹部超声/CT 及相关肿瘤标志物。

【易漏得分点】

黄疸题必须写“尿胆红素、尿胆原”。

梗阻性黄疸要写 ALP、GGT、DBIL 和胆管扩张。

肝癌题要写乙肝史、AFP、肝占位。

1.6 模板 4：贫血/溶血/白血病/DIC 类 【题型】

面色苍白、乏力、心慌、出血点、鼻出血、黄疸、脾大、全血细胞减少、骨髓异常、凝血异常。

【题干关键词】

Hb 降低提示贫血；MCV/MCH/MCHC 降低提示小细胞低色素性贫血；网织红细胞升高提示骨髓代偿或溶血；Coombs 阳性提示自身免疫性溶血；PT 延长、FIB 降低、FDP/D-D 升高提示 DIC。

【需要先判断什么】

先判断贫血类型，再判断是否合并出血/凝血障碍。

【答题步骤】

1. 先写贫血或血液病诊断。
2. 写贫血表现：乏力、苍白、心慌、Hb 降低。
3. 写分类依据：MCV/MCH、Ret、铁代谢、胆红素、Coombs、骨髓。
4. 若有出血，写 PLT、PT、APTT、FIB、FDP/D-D。
5. 鉴别其他贫血或出血性疾病。

【必须写出的检验依据】

缺铁性贫血：Hb 降低 + MCV/MCH/MCHC 降低 + 血清铁降低，常有慢性失血或月经过多。

溶血性贫血：贫血 + 黄疸 + Ret 升高 + 间接胆红素升高 + 尿胆红素阴性/尿胆原强阳性。

自身免疫性溶血：Coombs 试验阳性。

再生障碍性贫血：贫血、感染、出血 + 全血细胞减少 + Ret 低 + 骨髓增生低下。

急性白血病：贫血、发热、出血 + 外周血幼稚细胞 + 骨髓原始/幼稚细胞增多。

DIC：出血 + PT 延长 + FIB 降低 + FDP/D-D 升高。

【鉴别诊断】

缺铁性贫血：慢性病贫血、地中海贫血、铁幼粒细胞贫血。

溶血性贫血：急性黄疸型肝炎、药物性溶血、继发性免疫性溶血。

急性白血病：再障、类白血病反应、其他类型白血病。

DIC：血小板减少性紫癜、单纯凝血因子缺乏、原发性纤溶。

【补充检查】

血常规和红细胞参数、网织红细胞、铁蛋白、血清铁、总铁结合力、骨髓检查和铁染色、溶血指标、Coombs 试验、肝功能、凝血功能、FIB、FDP/D-D、骨髓免疫分型和遗传学检查。

【考场可直接套用答案】

本例考虑贫血/血液系统疾病，依据为乏力、苍白及 Hb 降低。若 MCV、MCH、MCHC 降低并有血清铁降低，支持缺铁性贫血；若贫血伴黄疸、网织红细胞升高、间接胆红素升高，支持溶血性贫血；若有出血并 PT 延长、FIB 降低、FDP/D-D 升高，应考虑 DIC。建议完善铁代谢、网织红细胞、骨髓检查、溶血指标及凝血功能。

【易漏得分点】

贫血题不要只写 Hb，要写 MCV/MCH/MCHC 或 Ret。

溶血题一定写间接胆红素、尿胆红素、尿胆原、Coombs。

DIC 题一定写 PT、FIB、FDP/D-D。

1.7 模板 5：肾功能/尿液/泌尿系统类 【题型】

血尿、蛋白尿、少尿、水肿、高血压、肾区叩痛、尿频尿急尿痛、BUN/Cr 升高。

【题干关键词】

感染后 1-3 周出现水肿、血尿、蛋白尿、高血压，考虑急性肾小球肾炎；尿路刺激征 + 发热 + 肾区叩痛，考虑肾盂肾炎；腰痛 + 活动后血尿，考虑结石或泌尿系统损伤。

【需要先判断什么】

先区分肾小球病变、尿路感染、结石/外伤。

【答题步骤】

1. 写主要诊断：急性肾小球肾炎、肾盂肾炎、结石、肾外伤等。
2. 写尿异常：血尿、蛋白尿、管型、尿 WBC。
3. 写肾功能：BUN、Cr、尿量。
4. 写病因线索：咽部感染、ASO、C3、痛风、外伤。
5. 鉴别其他肾炎、IgA 肾病、尿路感染、肿瘤。

【必须写出的检验依据】

尿蛋白阳性 + 镜下血尿 + 管型：支持肾小球病变。

BUN/Cr 升高：提示肾功能受损。

C3 降低 + ASO 升高 + 感染后血尿水肿：支持链球菌感染后急性肾炎。

尿 WBC 增多 + 尿培养阳性：支持尿路感染。

肉眼血尿 + 尿 RBC 满视野 + 外伤史：支持泌尿系统损伤。

【鉴别诊断】

急性肾炎：IgA 肾病、急进性肾炎、膜增殖性肾炎、SLE 肾炎。

肾盂肾炎：膀胱炎、肾结核、尿路结石。

血尿/结石：输尿管肿瘤、尿路感染、肾外伤。

【补充检查】

尿常规、尿沉渣、24h 尿蛋白、尿培养 + 药敏、BUN、Cr、eGFR、电解质、C3、ASO、ANA 谱、泌尿系 B 超/CT、必要时肾活检。

【考场可直接套用答案】

本例考虑肾脏或泌尿系统病变，依据为水肿/腰痛/尿路刺激征，伴尿蛋白或血尿。若尿蛋白、镜下血尿、管型并有 BUN/Cr 升高，提示肾小球受累及肾功能损害；若 C3 降低、ASO 升高并有上呼吸道感染史，支持链球菌感染后急性肾小球肾炎。建议完善尿沉渣、肾功能、电解质、补体/免疫指标、泌尿系影像，必要时肾活检。

【易漏得分点】

血尿题要写尿 RBC。

肾炎题要写 C3 和 ASO。

肾功能损害题要写 BUN、Cr 和尿量。

1.8 模板 6：体液检查类 【题型】

胸腔积液、腹水、脑脊液异常。

【题干关键词】

低热盗汗消瘦 + 胸水：考虑结核性胸膜炎。

发热、胸痛、胸水 WBC 高、多核细胞为主、pH 低：考虑脓胸。

中老年、血性胸水、消瘦：考虑恶性胸水。

高热、头痛、喷射性呕吐、脑膜刺激征：考虑脑膜炎。

【需要先判断什么】

胸水/腹水先判断渗出液还是漏出液，再判断病因。脑脊液先判断化脓性、结核性、病毒性。

【答题步骤】

1. 写积液或脑膜炎诊断。
2. 写临床线索：发热、盗汗、胸痛、腹水、头痛呕吐、脑膜刺激征。
3. 写体液检查：细胞数及分类、蛋白、糖、氯化物、LDH、ADA、培养、细胞学。
4. 鉴别结核、化脓、恶性、漏出性。

【必须写出的检验依据】

胸水 ADA 升高 + 淋巴细胞为主：支持结核性胸水。

胸水 WBC 明显升高 + 中性粒细胞为主 + pH 降低：支持脓胸。

血性胸水 + 细胞学找到肿瘤细胞：支持恶性胸水。

脑脊液糖降低、蛋白升高、细胞数增多：提示感染性脑膜炎，需结合分类和病原学鉴别。

【鉴别诊断】

结核性胸水、脓胸、恶性胸水、心衰性胸水。

化脓性脑膜炎、结核性脑膜炎、病毒性脑膜炎。

【补充检查】

胸水/腹水常规、生化、蛋白、LDH、糖、ADA、细胞分类、培养 + 药敏、细胞学；脑脊液压力、外观、常规、生化、涂片、培养；必要时胸片/CT、胸膜活检。

【考场可直接套用答案】

本例考虑体液相关疾病，应根据积液常规、生化和病原学判断性质。若胸水为渗出液、淋巴细胞为主且 ADA 升高，支持结核性胸膜炎；若 WBC 显著升高、中性粒细胞为主、pH 降低，支持脓胸。建议完善积液常规、生化、ADA、培养、细胞学及影像学检查。

【易漏得分点】

胸水题一定写 ADA、细胞分类、pH/糖/LDH。

脑膜炎题一定写腰穿和脑脊液常规、生化、细菌学。
恶性积液要写细胞学或活检。

1.9 模板 7: 消化道出血/消化道肿瘤类 【题型】

黑便、呕血、便潜血阳性、贫血、消瘦、腹部包块、CEA 升高。

【题干关键词】

黑便/柏油样便、呕血、Hb 降低、便潜血阳性；胃部不适、体重下降；排便习惯改变、暗红色血便、右下腹包块。

【需要先判断什么】

先判断是否有消化道出血，再判断出血来源或肿瘤可能。

【答题步骤】

1. 写上消化道出血、胃癌、结肠癌、胃溃疡合并出血等。
2. 写出血证据：黑便、呕血、便潜血阳性、Hb 降低。
3. 写肿瘤线索：消瘦、食欲下降、腹部包块、CEA 升高、影像异常。
4. 鉴别溃疡、胃癌、食管胃底静脉曲张、炎症性肠病等。
5. 补充内镜和病理。

【必须写出的检验依据】

Hb 降低：提示贫血或失血。

便潜血阳性：提示消化道出血。

CEA 升高可支持消化道肿瘤，但不能单独确诊。

内镜 + 活检病理是胃肠道肿瘤确诊关键。

【鉴别诊断】

上消化道出血：溃疡、胃癌、食管胃底静脉曲张破裂、胆道出血。

结肠癌：炎症性肠病、肠结核、阿米巴痢疾。

胃癌：胃溃疡、胃炎。

【补充检查】

血常规、便潜血、肝功能、凝血功能、胃镜/肠镜、活检病理、腹部 B 超/CT、肿瘤标志物。

【考场可直接套用答案】

本例考虑消化道出血或消化道肿瘤，依据为黑便/血便、便潜血阳性及 Hb 降低；若伴消瘦、腹部包块或 CEA 升高，应考虑肿瘤可能。建议完善血常规、便潜血复查、胃镜或结肠镜及活检病理、腹部影像和肿瘤标志物。

【易漏得分点】

消化道肿瘤不能只靠 CEA，必须写内镜和病理。

出血题要写 Hb、便潜血、生命体征。

乙肝肝硬化背景的呕血黑便要想到食管胃底静脉曲张破裂。

1.10 模板 8: 内分泌/代谢/中毒类 【题型】

糖尿病、甲亢、有机磷中毒、一氧化碳中毒、脱水和酸碱电解质问题。

【题干关键词】

多饮、多尿、多食、体重下降；怕热多汗、心悸、消瘦、突眼、甲状腺肿大；昏迷、煤炉、口唇樱桃红；农药接触、瞳孔缩小、大汗、流涎。

【需要先判断什么】

先判断是代谢性疾病还是急性中毒；急症题要写关键特异检查。

【答题步骤】

1. 写诊断：2 型糖尿病、甲亢、CO 中毒、有机磷中毒等。
2. 写症状体征。

3. 写特异实验室检查。
4. 写鉴别诊断。
5. 写进一步检查以确认和判断严重程度。

【必须写出的检验依据】

糖尿病：空腹血糖、OGTT、HbA1c、尿糖、尿酮体。

甲亢：T3/T4 升高、TSH 降低，必要时甲状腺摄碘率。

CO 中毒：碳氧血红蛋白定性/定量，血气分析。

有机磷中毒：胆碱酯酶活性降低。

脱水/腹泻：电解质、血气、CO₂-CP、肾功能。

【鉴别诊断】

甲亢：单纯性甲状腺肿、神经官能症、结核或恶性肿瘤。

CO 中毒：脑血管病、安眠药中毒、肝昏迷、尿毒症、糖尿病酮症酸中毒。

有机磷中毒：其他农药中毒、食物中毒、脑血管意外。

【补充检查】

血糖、OGTT、HbA1c、尿糖/尿酮体；T3、T4、TSH、甲状腺超声；碳氧血红蛋白、血气分析；胆碱酯酶；电解质、肾功能。

【考场可直接套用答案】

本例考虑内分泌代谢或中毒性疾病，依据为典型症状、体征及相关暴露史。糖尿病需完善血糖、OGTT、HbA1c、尿糖和尿酮体；甲亢需完善 T3、T4、TSH；CO 中毒需查碳氧血红蛋白和血气；有机磷中毒需查胆碱酯酶活性。

【易漏得分点】

甲亢题不要忘 TSH。

CO 中毒题要写碳氧血红蛋白。

腹泻脱水题要写电解质和血气。

1.11 模板 9：外伤/急腹症/休克类 【题型】

腹部外伤、脾破裂、肠管破裂、异位妊娠破裂、肾外伤、骨折、硬膜外血肿。

【题干关键词】

明确外伤史、腹痛加重、腹膜刺激征、移动性浊音、Hb 降低、血压下降、脉快、血尿、意识障碍。

【需要先判断什么】

先判断是否出血、休克、脏器破裂或重要器官损伤。

【答题步骤】

1. 写外伤或急腹症诊断。
2. 写外伤机制或诱因。
3. 写体征：腹膜刺激征、移动性浊音、局部畸形、神经定位体征。
4. 写实验室：Hb 降低、WBC 升高、尿 RBC。
5. 写影像或穿刺检查。

【必须写出的检验依据】

Hb 降低 + 脉快/血压低：提示失血。

尿 RBC 满视野/肉眼血尿：支持泌尿系统损伤。

WBC 升高可支持炎症或应激，但不能单独确诊。

腹腔穿刺抽出不凝血或异常液体可支持腹腔内出血/空腔脏器破裂。

【鉴别诊断】

腹部外伤：肝破裂、脾破裂、肠破裂、单纯腹壁损伤。

肾外伤：肝脏破裂、肠破裂。

硬膜外血肿：硬膜下血肿、脑内血肿。

异位妊娠：黄体破裂、急性阑尾炎、卵巢囊肿蒂扭转。

【补充检查】

血常规动态复查、凝血功能、腹部 B 超/CT、腹腔穿刺、尿常规、泌尿系 CT、头颅 CT、X 线。

【考场可直接套用答案】

本例考虑外伤或急腹症相关疾病，依据为明确诱因，随后出现局部疼痛、腹膜刺激征或出血休克表现；若 Hb 降低、脉快、血压下降，提示失血；若肉眼血尿或尿 RBC 满视野，提示泌尿系统损伤。建议完善血常规动态复查、腹部/泌尿系/头颅影像及必要的穿刺检查。

【易漏得分点】

外伤题要写“外伤机制”。

休克题要写 Hb、脉搏、血压。

颅脑外伤题要写中间清醒期和头颅 CT。

1.12 模板 10：自身免疫/风湿免疫相关类 【题型】

年轻女性、发热、关节痛、口腔溃疡、贫血、尿蛋白、血尿、Coombs 阳性。

【题干关键词】

年轻女性、多系统受累、关节痛、口腔溃疡、肾损害、血液系统异常、自身抗体。

【需要先判断什么】

先判断是否多系统受累，再找免疫学证据。

【答题步骤】

1. 写 SLE 或继发性自身免疫性溶血性贫血可能。
2. 写多系统表现：关节、口腔、肾脏、血液系统。
3. 写实验室：Hb、Ret、尿蛋白/血尿、Coombs、ANA 谱、补体。
4. 鉴别原发性溶血、肝炎、药物性溶血等。

【必须写出的检验依据】

Coombs 阳性支持自身免疫性溶血。

尿蛋白/血尿提示肾脏受累。

ANA 谱、抗 dsDNA、补体 C3/C4 用于 SLE 诊断和活动性判断。

Hb 降低 + Ret 升高 + 间接胆红素升高支持溶血。

【鉴别诊断】

原发性免疫性溶血性贫血、药物性溶血、急性黄疸型肝炎、其他风湿免疫病。

【补充检查】

ANA 谱、抗 dsDNA、抗 Sm、补体 C3/C4、免疫球蛋白、尿常规、肾功能、骨髓检查、溶血指标。

【考场可直接套用答案】

本例考虑自身免疫相关疾病，依据为年轻女性、多系统表现，并有血液系统或肾脏受累。若 Coombs 阳性、Hb 降低、Ret 升高及间接胆红素升高，支持自身免疫性溶血；若有尿蛋白或血尿，提示肾脏受累。建议完善 ANA 谱、抗 dsDNA、补体、免疫球蛋白、尿常规及肾功能检查。

【易漏得分点】

SLE 题要写“多系统受累”。

免疫性溶血题要写 Coombs。

肾受累要写尿蛋白、尿 RBC、肾功能。

- 第 1 题 → 心肌损伤/心衰/胸痛类 → 高血压性心脏病、心房纤颤、心功能不全。
第 2 题 → 感染/炎症类 → 左侧肺炎, WBC 和中性粒细胞升高。
第 3 题 → 内分泌/代谢/中毒类 → 急性一氧化碳中毒, 碳氧血红蛋白和血气。
第 4 题 → 心肌损伤/心衰/胸痛类 → 急性心肌梗死、糖尿病 2 型。
第 5 题 → 黄疸/肝胆胰类 → 梗阻性黄疸, 胰头或壶腹周围癌可能。
第 6 题 → 肾功能/尿液/泌尿系统类 → 右输尿管结石, 血尿、肾积水、尿酸高。
第 7 题 → 消化道出血/消化道肿瘤类 → 胃癌, 便潜血阳性、贫血、胃镜病理。
第 8 题 → 心肌损伤/心衰/胸痛类 → 急性前壁心肌梗死。
第 9 题 → 贫血/溶血/白血病/DIC 类 → 缺铁性贫血, 消化道肿瘤可能。
第 10 题 → 感染/炎症类 → 肺结核, 慢性咳嗽、低热盗汗、结核检查。
第 11 题 → 心肌损伤/心衰/胸痛类 → 不稳定性心绞痛, 高血压病。
第 12 题 → 黄疸/肝胆胰类 → 急性重症胰腺炎, 淀粉酶和影像。
第 13 题 → 黄疸/肝胆胰类 → 梗阻性黄疸待查, 胆道肿瘤。
第 14 题 → 消化道出血/消化道肿瘤类 → 胃溃疡合并出血, 黑便、Hb 降低。
第 15 题 → 感染/炎症类 → 胆总管结石、化脓性胆管炎。
第 16 题 → 内分泌/代谢/中毒类 → 2 型糖尿病, 血糖、尿糖、尿酮体。
第 17 题 → 肾功能/尿液/泌尿系统类 → 慢性肾盂肾炎急性发作。
第 18 题 → 外伤/急腹症/休克类 → 急性弥漫性腹膜炎、急性胰腺炎。
第 19 题 → 黄疸/肝胆胰类 → 梗阻性黄疸, 胆总管结石。
第 20 题 → 外伤/急腹症/休克类 → 急性阑尾炎, WBC 升高和右下腹体征。
第 21 题 → 外伤/急腹症/休克类 → 异位妊娠破裂出血, 休克和腹腔内出血。
第 22 题 → 心肌损伤/心衰/胸痛类 → 心包堵塞/血心包。
第 23 题 → 体液检查类 → 右侧胸腔积液, 结核性胸膜炎。
第 24 题 → 内分泌/代谢/中毒类 → Graves 病、甲亢性心脏病。
第 25 题 → 内分泌/代谢/中毒类 → 急性有机磷农药中毒, 胆碱酯酶。
第 26 题 → 感染/炎症类 → 慢性菌痢, 便常规、便培养。
第 27 题 → 资料编号缺失 → 资料未覆盖, 疑似原 PDF 漏号。
第 28 题 → 贫血/溶血/白血病/DIC 类 → 急性白血病, 骨髓检查。
第 29 题 → 贫血/溶血/白血病/DIC 类 → 慢性再生障碍性贫血。
第 30 题 → 肾功能/尿液/泌尿系统类 → 肾结核、附睾结核、膀胱挛缩。
第 31 题 → 贫血/溶血/白血病/DIC 类 → 自身免疫性溶血性贫血。
第 32 题 → 贫血/溶血/白血病/DIC 类 → 急性早幼粒细胞白血病合并 DIC。
第 33 题 → 内分泌/代谢/中毒类 → 原发性甲亢。
第 34 题 → 外伤/急腹症/休克类 → 右髌关节后脱位。
第 35 题 → 外伤/急腹症/休克类 → 肾外伤, 肉眼血尿。
第 36 题 → 外伤/急腹症/休克类 → 肾外伤, 重复病例。
第 37 题 → 黄疸/肝胆胰类 → 原发性肝癌, 乙肝史、AFP、肝占位。
第 38 题 → 消化道出血/消化道肿瘤类 → 上消化道出血, 食管静脉曲张破裂可能。
第 39 题 → 消化道出血/消化道肿瘤类 → 结肠癌, 便潜血、贫血、CEA。
第 40 题 → 贫血/溶血/白血病/DIC 类 → 缺铁性贫血, 月经过多。
第 41 题 → 外伤/急腹症/休克类 → 急性肠梗阻。
第 42 题 → 体液检查类 → 化脓性脑膜炎, 脑脊液检查。
第 43 题 → 感染/炎症类 → 支气管肺炎、心力衰竭。
第 44 题 → 内分泌/代谢/中毒类 → 婴儿腹泻、重度脱水, 电解质和血气。
第 45 题 → 感染/炎症类 → 中毒型细菌性痢疾。
第 46 题 → 外伤/急腹症/休克类 → 右肱骨髁上骨折。
第 47 题 → 黄疸/肝胆胰类 → 急性黄疸型肝炎。
第 48 题 → 体液检查类 → 流行性脑脊髓膜炎, 脑脊液和血培养。
第 49 题 → 外伤/急腹症/休克类 → 脾破裂、腹腔内出血。
第 50 题 → 肾功能/尿液/泌尿系统类 → 链球菌感染后急性肾小球肾炎。
第 51 题 → 自身免疫/风湿免疫相关类 → SLE 继发自身免疫性溶血。
第 52 题 → 外伤/急腹症/休克类 → 肠管破裂, 小肠破裂可能。
第 53 题 → 外伤/急腹症/休克类 → 右额颞急性硬膜外血肿。

1.13 Part 3: 53 题归类索引

1.14 Part 4: 最后 20 分钟背诵版

结论句：本例考虑 _____ 感染。

依据句：急性起病，发热，伴局部症状；WBC 升高、中性粒细胞比例升高，提示细菌感染。

鉴别句：需与结核、肿瘤或其他病原体感染鉴别。

补查句：完善血/痰/便/脑脊液培养加药敏，必要时影像或体液检查。

1. 感染题

结论句：本例考虑急性冠脉综合征/急性心肌梗死，必要时合并心衰。

依据句：持续胸痛、硝酸甘油缓解差，伴危险因素；心电图和心肌标志物可支持诊断。

鉴别句：需与心绞痛、主动脉夹层、肺栓塞鉴别。

补查句：完善心电图动态观察、cTn、CK-MB、心脏超声、血气和电解质。

2. 心梗/心衰题

结论句：本例考虑黄疸原因待查，_____ 性黄疸可能性大。

依据句：皮肤巩膜黄染、尿色深；结合胆红素/转氨酶/ALP/GGT 异常提示相应类型。

鉴别句：需与肝细胞性、梗阻性、溶血性黄疸鉴别。

补查句：完善肝功能、胆红素分型、尿胆红素/尿胆原、肝炎标志物、腹部 B 超/CT。

3. 黄疸题

结论句：本例考虑 _____ 贫血。

依据句：乏力苍白、Hb 降低；结合 MCV/MCH、Ret、铁代谢或溶血指标判断类型。

鉴别句：需与缺铁性贫血、慢性病贫血、溶血性贫血、再障鉴别。

补查句：完善红细胞参数、Ret、铁代谢、骨髓检查、Coombs 和溶血指标。

4. 贫血/溶血题

结论句：本例考虑急性白血病，若有出血和凝血异常，应考虑合并 DIC。

依据句：贫血、发热、出血，外周血幼稚细胞或骨髓原始/早幼粒细胞增多；PT 延长、FIB 降低、

↳ FDP/D-D 升高支持 DIC。

鉴别句：需与再障、其他白血病、单纯血小板减少或其他出血病鉴别。

补查句：完善骨髓免疫分型、细胞遗传学、凝血功能、FIB、FDP/D-D。

5. DIC/白血病题

结论句：本例考虑 _____ 肾脏/泌尿系统疾病。

依据句：水肿、少尿、血尿/蛋白尿；BUN、Cr 升高提示肾功能受损。

鉴别句：需与 IgA 肾病、急进性肾炎、尿路感染、结石或肿瘤鉴别。

补查句：完善尿沉渣、24h 尿蛋白、肾功能、电解质、C3/ASO/ANA、泌尿系影像，必要时肾活检。

6. 肾炎/尿液题

结论句：本例考虑 _____ 积液/脑膜炎。
依据句：结合发热、胸痛/头痛呕吐及体液常规、生化、细胞分类判断病因。
鉴别句：胸水需鉴别结核性、化脓性、恶性和漏出性；脑膜炎需鉴别化脑、结脑、病脑。
补查句：完善体液压力/外观/常规/生化/培养/细胞学，必要时影像或活检。

7. 胸水/脑脊液题

结论句：本例考虑消化道出血/消化道肿瘤可能。
依据句：黑便、呕血或血便，便潜血阳性，Hb 降低；消瘦、包块、CEA 升高提示肿瘤可能。
鉴别句：需与溃疡、胃癌、结肠癌、炎症性肠病、肠结核鉴别。
补查句：完善血常规、便潜血、胃镜/肠镜、活检病理、腹部影像和肿瘤标志物。

8. 消化道出血/肿瘤题

结论句：本例考虑 _____。
依据句：结合典型症状和特异检查，如血糖/HbA1c、T3/T4/TSH、碳氧血红蛋白、胆碱酯酶。
鉴别句：需与相似代谢病、中毒或神经系统疾病鉴别。
补查句：完善对应特异检查及血气、电解质、肝肾功能。

9. 甲亢/糖尿病/中毒题

结论句：本例考虑 _____ 损伤/急腹症。
依据句：有明确外伤或急腹症表现，伴局部体征；Hb 降低、脉快、血压下降提示出血。
鉴别句：需与其他脏器损伤或单纯软组织损伤鉴别。
补查句：完善血常规动态复查、B 超/CT、X 线、腹腔穿刺或头颅 CT。

10. 外伤/急腹症题

一、诊断
本例考虑 _____ 可能性大。

二、诊断依据

1. 病史：患者有 _____。
2. 体征：查体见 _____。
3. 实验室：_____ 升高/降低/阳性，提示 _____。

三、鉴别诊断
需与 _____、_____、_____ 鉴别，主要鉴别点为 _____。

四、进一步检查
建议完善 _____、_____、_____，以明确诊断并判断病情。

1.15 最后一页：不会写时的保底答案

1.16 Part 5: 主观题示范答案骨架 这一部分专门解决“我不会写病例分析题”的问题。考试时不要逐字照抄病名，按题干替换空格即可。

一、诊断

本例考虑肺部感染，_____ 肺炎可能性大。

二、诊断依据

1. 病史：急性起病，发热/寒战，伴咳嗽、咳痰，符合肺部感染表现。
2. 体征：肺部叩浊、语颤增强、湿啰音或支气管呼吸音，提示肺实变或肺部炎症。
3. 实验室及辅助检查：WBC 升高，中性粒细胞比例升高，提示细菌感染；胸片/CT 可见肺部实变
→ 或斑片影。

三、鉴别诊断

1. 肺结核：多有低热、盗汗、消瘦、病程较长及上肺病灶。
2. 肺脓肿：常有大量臭脓痰及空洞液平。
3. 肺癌：多见于中老年，病程较长，可有占位、阻塞或痰中带血。

四、进一步检查

完善胸片或胸部 CT、痰涂片/培养加药敏、血培养，必要时查 CRP/PCT。

1. 肺部感染类示范

一、诊断

本例考虑 _____ 性胸腔积液。

二、诊断依据

1. 病史：有胸痛、气促或低热盗汗/高热/消瘦等表现。
2. 体征：患侧语颤减弱、叩诊浊音、呼吸音减弱或消失，支持胸腔积液。
3. 胸水依据：胸水蛋白/LDH 升高提示渗出液；ADA、WBC、细胞分类、pH、糖、细胞学用于病因判
→ 断。

三、鉴别诊断

1. 结核性胸水：低热盗汗消瘦，ADA>45U/L，淋巴细胞为主。
2. 脓胸：高热，胸水 WBC 明显升高，中性粒细胞为主，pH 降低。
3. 恶性胸水：中老年、血性胸水，ADA 可低，细胞学或活检阳性。

四、进一步检查

完善胸水常规、生化、ADA、细菌培养、结核相关检查、细胞学检查，必要时胸膜活检或胸腔镜。

2. 胸水类示范

一、诊断

本例考虑黄疸原因待查，_____ 性黄疸可能性大。

二、诊断依据

1. 病史：皮肤巩膜黄染、尿色深、皮肤瘙痒/乏力纳差/右上腹痛。
2. 体征：皮肤巩膜黄染，肝区压痛或肝脾肿大。
3. 实验室：TBIL 升高；若 DBIL、ALP、GGT 升高明显，支持梗阻或胆汁淤积；若 ALT/AST 升高明
→ 显，支持肝细胞损伤；若 IBIL 升高伴尿胆红素阴性，考虑溶血。

三、鉴别诊断

1. 肝细胞性黄疸：转氨酶升高明显，常有乏力、纳差、肝炎标志物异常。
2. 梗阻性黄疸：DBIL、ALP、GGT 升高明显，可有胆管扩张。
3. 溶血性黄疸：贫血、Ret 升高、IBIL 升高，尿胆红素阴性。

四、进一步检查

完善肝功能、胆红素分型、尿胆红素/尿胆原、肝炎病毒标志物、腹部 B 超/CT/MRCP，必要时查
↳ AFP 或病理。

3. 黄疸类示范

一、诊断

本例考虑 _____ 性贫血。

二、诊断依据

1. 病史：乏力、头晕、面色苍白、心悸，或月经过多/黑便/尿色深等病因线索。
2. 体征：贫血貌、结膜苍白；若有黄疸、脾大，提示溶血可能。
3. 实验室：Hb 降低提示贫血；MCV/MCH/MCHC 判断细胞大小和色素；Ret、铁代谢、胆红素、Coombs
↳ 或骨髓检查判断病因。

三、鉴别诊断

1. 缺铁性贫血：小细胞低色素，血清铁/铁蛋白降低，多有慢性失血。
2. 巨幼细胞性贫血：MCV 增大，叶酸或 Vit B12 缺乏。
3. 溶血性贫血：Ret 升高、IBIL 升高、尿胆原升高，Coombs 可阳性。
4. 再障：全血细胞减少、Ret 低、骨髓增生低下。

四、进一步检查

完善血常规红细胞参数、Ret、铁蛋白、血清铁、总铁结合力、叶酸/Vit B12、溶血指标、Coombs
↳ 试验及骨髓检查。

4. 贫血类示范

一、诊断

本例考虑急性白血病，若有凝血异常，考虑合并 DIC。

二、诊断依据

1. 病史：发热、乏力、出血倾向，如鼻出血、皮肤瘀斑。
2. 体征：贫血貌、出血点、胸骨压痛、肝脾或淋巴结肿大。
3. 实验室：血常规可有贫血、血小板减少、白细胞异常；外周血或骨髓见原始/幼稚细胞增多。若
↳ PT/APTT 延长、FIB 降低、FDP/D-D 升高，支持 DIC。

三、鉴别诊断

1. 再生障碍性贫血：全血细胞减少但骨髓增生低下，无白血病性原始细胞增多。
2. 类白血病反应：有感染等诱因，骨髓不符合白血病。
3. 单纯血小板减少：以 PLT 减少为主，无白血病骨髓改变和 DIC 组合。

四、进一步检查

完善骨髓细胞学、细胞化学染色、免疫分型、染色体/融合基因检查，以及 PT、APTT、FIB、FDP、
↳ D-D、血生化。

5. 白血病/DIC 类示范

一、诊断

本例考虑 _____ 肾小球肾炎/泌尿系统疾病。

二、诊断依据

1. 病史：上呼吸道感染后出现水肿、少尿、肉眼或镜下血尿，可伴高血压。
2. 体征：眼睑或下肢水肿，血压升高。
3. 实验室：尿蛋白阳性、尿 RBC 增多或管型提示肾小球受累；BUN/Cr 升高提示肾功能受损；C3 降低、ASO 升高支持链球菌感染后急性肾炎。

三、鉴别诊断

1. IgA 肾病：常在上感后 1-3 天即出现血尿。
2. 急进性肾炎：少尿/无尿明显，Cr 重度升高，病情进展快。
3. SLE 肾炎：有发热、关节痛、皮疹、口腔溃疡及自身抗体异常。
4. 尿路感染：尿频尿急尿痛，尿 WBC 增多，尿培养阳性。

四、进一步检查

完善尿沉渣、24h 尿蛋白、BUN、Cr、eGFR、电解质、C3、ASO、ANA 谱、泌尿系 B 超，必要时肾活检。

6. 肾炎/尿液类示范

一、诊断

本例考虑急性心肌梗死/心力衰竭可能。

二、诊断依据

1. 病史：持续胸痛，硝酸甘油缓解差，伴大汗、呼吸困难；或有夜间阵发性呼吸困难、不能平卧。
2. 体征：肺底湿啰音支持左心衰；颈静脉怒张、肝大、肝颈静脉回流征阳性、下肢水肿支持右心衰。
3. 实验室及辅助检查：心电图改变和 cTn/CK-MB 升高支持心肌梗死；血气、电解质和心脏超声用于判断病情。

三、鉴别诊断

1. 心绞痛：疼痛时间较短，硝酸甘油有效，心肌坏死标志物不升高。
2. 主动脉夹层：撕裂样疼痛，可有血压或脉搏差。
3. 肺栓塞：突发呼吸困难胸痛，P2 亢进，低氧，CTPA 支持。

四、进一步检查

完善心电图动态观察、cTn、CK-MB、肌红蛋白、心脏超声、胸片、血气、电解质、血糖血脂和肝肾功能。

7. 心梗/心衰类示范

一、诊断

本例考虑 _____ 脑膜炎。

二、诊断依据

1. 病史：发热、头痛、频繁喷射性呕吐，可有流行病学接触史。
2. 体征：脑膜刺激征阳性，如颈抵抗、Kernig 征、Brudzinski 征。
3. 实验室：血 WBC 和中性粒细胞升高提示细菌感染；脑脊液压力、外观、细胞分类、蛋白、糖、氯化物用于鉴别脑膜炎类型。

三、鉴别诊断

1. 化脓性脑膜炎：起病急，高热，CSF 中性粒细胞为主，糖降低。
2. 结核性脑膜炎：病程较慢，CSF 糖和氯化物降低，蛋白升高，淋巴细胞为主。
3. 病毒性脑膜炎：CSF 糖多正常，病情相对轻。

四、进一步检查

完善腰穿测压力、脑脊液外观、常规、生化、涂片、培养和药敏，必要时血培养、皮肤瘀点涂片、
↳ 头颅影像。

8. 脑膜炎/脑脊液类示范

1.17 Part 6: 主观题阅卷友好写法

不要写：肺部有问题。

要写：左侧肺炎，肺炎链球菌感染可能性大。

不要写：贫血。

要写：缺铁性贫血，月经过多所致可能性大。

不要写：黄疸。

要写：黄疸原因待查，梗阻性黄疸可能性大。

1. 诊断写法

不要只写：病人发热。

要写：急性起病，寒战高热，伴咳嗽咳痰；WBC 升高、中性粒细胞比例升高，提示细菌感染。

不要只写：病人黄。

要写：皮肤巩膜黄染，尿胆红素阳性；DBIL、ALP、GGT 升高明显，提示胆汁淤积或梗阻性黄疸。

不要只写：尿不正常。

要写：尿蛋白阳性、镜下血尿及管型，提示肾小球受累；BUN/Cr 升高提示肾功能受损。

2. 依据写法

不要写：鉴别肺结核、肺癌。

要写：需与肺结核鉴别，后者多有低热盗汗、消瘦、病程长及上肺病灶；需与肺癌鉴别，后者多见于中老年，可有占位和痰中带血。

不要写：鉴别肝炎、梗阻。

要写：需与肝细胞性黄疸鉴别，后者 ALT/AST 升高更明显；需与溶血性黄疸鉴别，后者 Ret 和间接胆红素升高、尿胆红素阴性。

3. 鉴别写法

不要写：进一步检查。

要写：完善血常规复查、病原学检查、培养加药敏、胸部影像。

不要写：查肝功能。

要写：完善肝功能、胆红素分型、尿胆红素/尿胆原、肝炎病毒标志物、腹部 B 超或 CT。

不要写：查尿。

要写：完善尿沉渣、24h 尿蛋白、肾功能、电解质、C3、ASO、ANA 谱，必要时肾活检。

4. 补充检查写法